SDD 194 Sujet n°1

Spécialité : Endocrinologie

Date : 28/09/2023
Auteur : ELAYLI Robin (DES de psychiatrie - ECN 2023)
Relecteur(s) :

- VILLARD Sébastien (DES de médecine interne - ECN 2023)
- SAMANNI Léa (DES d'endocrinologie - ECN 2023)
- VILLETTE Ombeline (DES d'endocrinologie - ECN 2022)

Domaine d'apprentissage principal	Synthèse des résultats d'examen paraclinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Annonce/information au patient
Item(s) en lien avec la station	ITEM 243 Hyperthyroïdie
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 194 Analyse du bilan thyroïdien
Matériel nécessaire à la station	- Bilan biologique - Crayon - Feuille - 2 chaises - Bureau
Contexte de la station	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes endocrinologue en ville.
Vous recevez Mme Atras, 48ans, en consultation suite à la réception des résultats d'une prise de sang prescrite pour l'exploration d'une asthénie chronique qui semble d'après les résultats de la biologie être d'origine endocrinienne.

Dans ces antécédents, on retrouve une anxiété généralisée chronique, traitée par antidépresseurs. On retrouve un antécédent de cancer colorectal chez le père.
Votre examen clinique est normal. Vous ne percevez notamment pas de goitre thyroïdien, ni de signe d'orbitopathie.

Elle vous informe qu'elle a fait une échographie thyroïdienne et vous tend le résultat. Ce dernier indique : "Mise en évidence d'une thyroïde hypoéchogène et hypervascularisée au doppler. Absence de nodules"

Consignes :
Vous devez réaliser en 7 minutes :
- Interpréter les résultats du bilan sanguin endocrinologique
- Interpréter le reste du bilan sanguin, en énonçant à haute voix quelles anomalies sont dues à la pathologie en cause.
- Faire une annonce de la maladie diagnostiquée et expliquer les modalités de prise en charge possible

Vous ne devez pas :
- Faire un interrogatoire ou examen clinique
- Mettre en place les prises en charge évoquées
- Faire une prise en charge psychologique

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Analyse de la biologie			
1.	Identifie une hyperthyroïdie	1 pt	☐
2.	Identifie la cause de l'hyperthyroïdie (à savoir hyperthyroïdie de Basedow)	2 pt	☐
3.	Identifie dans la biologie comme anomalies en lien avec l'hyperthyroïdie (0,5 pt par élément) : ● Augmentation des enzymes hépatiques ● Baisse des triglycérides et du cholestérol ● Neutropénie OU Lymphocytose	1,5 pt	☐
Annonce			
4.	Annonce le diagnostic	1 pt	☐
5.	Explique la pathologie à la patiente (0,5 pt par élément) : ● Le fait que c'est une maladie dite "Auto-immune" ● Explique ce que signifie "auto-immun" : due à l'immunité du patient dirigé contre la thyroïde ● Explique la physiopathologie de façon succinct et compréhensive : L'immunité de la patiente active la production d'hormones thyroïdiennes qui sont ainsi produites en trop	1,5 pt	☐
6.	Évoque la possible rechute d'un épisode de sécrétion d'hormone	1 pt	☐
Explication des prises en charge possible			
7.	Parle des traitements non spécifiques possible pour aider la patiente lors des poussées (au moins 2 éléments) : ● Dit qu'il y a des traitements pour aider ● Parle de bêta-bloquants ● Parle de la nécessité de repos ● Parle de la possibilité d'un arrêt de travail ● Parle de sédatifs	1 pt	☐
8.	S'informe de l'état de ménopause de la patiente	0,5 pt	☐

9.	Parle du traitement spécifique de l'hyperthyroïdie de Basedow : les antithyroïdiens de synthèse	1 pt	☐
10.	Parle de la surveillance de l'agranulocytose des anti-thyroïdiens de synthèse (0,5 pt par élément) ● Nécessite une NFS tous les 10 jours ● Durée de ces NFS : Pendant 2 mois	1 pt	☐
11.	Parle de la nécessité de surveillance de l'efficacité du traitement (0,5 pt par élément) : ● Dosage T4L jusqu'à retour à la normal ● A la 3 - 4ème semaine pour le premier suivi	1 pt	☐
12.	Parle de la nécessité d'une surveillance à long terme pour toute la durée du traitement (0,5 pt par élément) : ● Dosage de TSH ● Tous les 3 mois	1 pt	☐
13.	Parle du traitement chirurgical possible de l'hyperthyroïdie de Basedow (0,5 pt par élément) : ● Parle de la chirurgie ● Explique que la chirurgie enlève toute la thyroïde ● Explique que l'opération nécessite de prendre des antithyroïdien de synthèse (ATS) avant ● Explique que ces ATS sont pris pour éviter une forte sécrétion d'hormone après la chirurgie ● Parle des risques de la chirurgie : parle de lésion des glande parathyroïde OU de lésion du nerf laryngée/des cordes vocale	2,5 pt	☐
14.	Parle du traitement par iode radioactif (0,5 pt par élément) : ● Parle de l'iode radioactif ● Explique que le but est de détruire les parties hyperactives/qui sécrètent trop ● Explique qu'une grossesse actuelle contre-indique ce traitement ● Explique qu'il faudra prendre une contraception 6 mois après le traitement	2 pt	☐

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)	

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

TOTAL (max 20 items)	/21 points

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

ATTENTION, concernant la mise en place de Bêta-bloquant du traitement non spécifique : Si on voulait les mettre en place, il nous faudrait un ECG.
Nous sommes ici cependant dans un dispositif d'annonce : On informe la patiente des possibilités thérapeutiques

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Patiente de 48ans vient consulter votre cabinet pour les résultats d'un bilan sanguin fait dans un contexte d'asthénie chronique. Elle vous apporte les résultats. Il est attendu de l'étudiant.e qu'il diagnostic la pathologie et fasse l'annonce diagnostic et de la prise en charge possible de cette pathologie.

Plan de la station ECOS :

Acteur/actrice face aux candidats.es, de part et d'autre d'un bureau

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

" Bonjour docteur. On m'a dit de vous donner cette prise de sang faite il y a peu et que vous alliez m'expliquez un peu la suite des évènements"

Identité du patient :

Mme Atras Agathe
48 ans
Femme
1m65, 59kg

Mode de vie :

Ostéopathe
Divorcée, 3 enfants
Pas de tabac, alcool occasionnel en petite quantité, pas d'allergie
Ménopause depuis 3ans

Comportement global :

Inquiète, en recherche d'informations

Antécédents personnels :

Trouble anxieux généralisé

Antécédents familiaux :

Cancer colorectal chez le père

Médicaments :

Traitement de fond : Sertraline (antidépresseur) pour le trouble anxieux généralisé

Donnée complémentaire :

Bilan biologique datant d'il y a 7 jours

Questions de relance :

- Si l'étudiant.e ne vous explique pas la maladie : "mais c'est quoi cette maladie, c'est due à quoi ? "
- Si l'étudiant.e ne vous a pas expliqué la suite de la prise en charge : "Bon… très bien, et maintenant qu'est ce qu'on va faire ?"
- Si l'étudiant.e propose un soutien psychologique "Ce sera peut être nécessaire, mais pas tout de suite, je suis suivi par un psychiatre je vais lui parler de tout cela déjà"
- Si l'étudiant.e ne vous parle pas des traitement non spécifiques des crises de thyroïdite : " mais cette fatigue que j'ai, je vais devoir la supporter sans rien pouvoir faire quand elle vient ?"
- Si l'étudiant.e ne vous parle pas d'un traitement curatif (la chirurgie) : "Et donc je vais avoir cela à vie ?"